

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Paracentesis Abdominus

معلومات الإقرار – نسخة المريض بزل البطن

1. What do I need to know about this procedure?

A Paracentesis Abdominus procedure is the drainage of fluid from the abdominal cavity through a large needle inserted through the abdomen.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

بزل البطن هو إجراء يتم فيه سحب السوائل من التجويف البطني بواسطة إبرة كبيرة يتم إدخالها عبر جدار البطن.

2. التخدير الذي أتلقيه

قد يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلق بالإجراء الطبي المقرر لك .
للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المحددة المتعلقة بهذا الإجراء؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely as the needle goes into the abdomen it may cause damage to blood vessels or part of the bowel or abdominal organs. This may need further surgery.
- The drainage tube may block and need cleaning out or replacement.
- After the drainage tube is removed, fluid may continue to leak from the insertion site, or the abdominal fluid may reaccumulate and need further drainage.

Notes to talk to my doctor about:

جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
• الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلق بهذا الإجراء:

- من النادر أن تسبب إبرة سحب السوائل أثناء دخولها إلى داخل البطن ضرراً لأحد للأوعية الدموية أو جزء من الأمعاء أو أعضاء البطن الداخلية. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- الأنبوب المخصص وسحب السوائل قد ينسد ويحتاج لتنظيف أو تغيير.
- بعد إخراج أنبوب سحب السوائل ، قد يستمر تسرب السوائل من موضع دخول الأنبوب أو قد تتجمع سوائل البطن مرة أخرى وتحتاج لسحب آخر.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
